



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING*
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

LEMBAR PENGESAHAN
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Tentang
Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

Penanggung Jawab:



Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Tim Pelayanan Stunting & Wasting Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kubutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Stunting & Wasting ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja Pelayanan Tim Stunting & Wasting ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 25 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PENGARAH: Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP.,CCHt.,CI.,CHAE.,CHQP

PENYUSUN:

1. dr. Fiona Paramitha, Sp.A
2. Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz
3. Ericha Risdawati, Amd. Gz
4. Sistha Ghea Aprilianti, Amd.Kep
5. Tuti Dwi Jayati, AMd. Kep
6. Apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
7. Yusrotul Widat, Amd. Kep
8. Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns
9. Mayputri Nabilla

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR.....ii

TIM PENYUSUNiii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR GAMBAR.....v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.....vi

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Maksud dan Tujuan.....1

BAB II PENGORGANISASIAN3

 2.1 Struktur Organisasi (SOTK).....3

 2.2 Susunan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*4

 2.3 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang4

 2.4 Tata Hubungan Kerja8

BAB III TATALAKSANA9

 3.1 Identifikasi dan Penetapan Pasien Risiko *Stunting* dan *Wasting*.....9

 3.2 Assesmen dan Penilaian Komprehensif9

 3.3 Penyusunan Rencana Pelayanan Terpadu.....10

 3.4 Pelaksanaan Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*10

 3.5 Monitoring Evaluasi Pasien *Stunting* dan *Wasting*10

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN11

BAB V PENUTUP12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SOTK Rumah Sakit..... 3

Gambar 2. SOTK Tim pelayanan Stunting dan Wasting..... 3



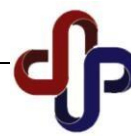
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 629.2/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING*

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan pelayanan *stunting dan wasting*;
- b. bahwa untuk mewujudkan poin a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Republik Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/d/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001/DPM/I-KEP/DIR/I/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING***

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Intervensi Gizi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting*, *wasting* dan gizi buruk seperti asupan makan, infeksi, status gizi Ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- (2) *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK;
- (3) *Wasting* adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang mencerminkan berat badan anak terlalu kurus menurut tinggi badannya, ditandai dengan z-score BB/TB kurang dari -2 SD untuk *wasting* dan z-score BB/TB kurang dari -3 SD untuk *severe wasting*.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Pembentukan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Rumah sakit membentuk Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* melalui Surat Keputusan Direktur;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan;
- (3) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* di Rumah Sakit dipimpin oleh staf medis atau dokter spesialis anak;
- (4) Yang termasuk dalam keanggotaan tim pelayanan *stunting* dan *wasting* antara lain:
 - a) Staf Medis;
 - b) Staf Keperawatan;
 - c) Staf Instalasi Gizi;
 - d) Staf Instalasi Farmasi;
 - e) Tim Humas.

Pasal 3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* bertugas menyelenggarakan pelayanan *stunting* dan *wasting* secara komprehensif dan terintegrasi;
- (2) Tim berfungsi:
 - a) Melakukan skrining terhadap pasien dengan risiko atau diagnosis *stunting* dan/atau *wasting*;
 - b) Menyusun rencana pelayanan terpadu;
 - c) Melaksanakan intervensi sesuai kompetensi;



- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan;
- e) Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang meliputi: pelayanan gizi, pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 4

Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* melaksanakan koordinasi secara terintegrasi untuk menjamin pelayanan yang berkesinambungan, berfokus pada pasien, serta memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien;
- (2) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* melaksanakan pertemuan berkala untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan;
- (3) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* bertanggung jawab melakukan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelayanan kepada Direktur Rumah Sakit sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB III

TATA LAKSANA

Pasal 5

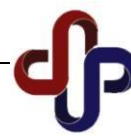
Pelaksanaan Asesemen *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Setiap pasien anak usia 6-59 bulan dengan dugaan masalah gizi wajib dilakukan asesmen *stunting* dan *wasting* sesuai indikasi klinis dan standar pelayanan;
- (2) Asesmen dilakukan secara komprehensif meliputi pengukuran antropometri (BB/U, TB/U, BB/TB atau IMT/U), riwayat asupan gizi, riwayat penyakit, serta faktor sosial ekonomi;
- (3) Asesmen dilakukan secara multidisiplin oleh tenaga kesehatan terkait dan terdokumentasi dalam rekam medis;
- (4) Hasil asesmen menjadi dasar dalam penentuan diagnosis gizi serta penyusunan rencana intervensi dan tindak lanjut pasien.

Pasal 6

Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- (1) Pelayanan *stunting* dan *wasting* diberikan di unit pelayanan rumah sakit meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap, serta unit terkait lainnya;
- (2) Pelayanan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mencakup edukasi gizi, intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- (3) Pelayanan dilaksanakan secara multidisiplin melibatkan tenaga medis, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien;
- (4) Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional, serta ketentuan yang berlaku;
- (5) Dilakukan koordinasi rujukan dan jejaring pelayanan untuk menjamin kesinambungan penanganan pasien *stunting* dan *wasting*.



BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan *stunting* dan *wasting* secara berkala;
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* menyusun laporan kegiatan dan capaian indikator mutu secara berkala;
- (2) Pelaporan hasil kegiatan dilaksanakan setiap bulan dan triwulan serta disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja;
- (3) Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* melaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan melalui aplikasi “PELITA KESMAS”.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 1079/I-KEP/DIR/X/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Tim *Stunting* dan *Wasting* sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 25 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR 629.2/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN
STUNTING DAN WASTING

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN STUNTING DAN WASTING

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Anak balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil merupakan kelompok rawan gizi yang sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi. Stunting, merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis menjadi isu serius di Indonesia saat ini dengan angka prevalensi mencapai 19,8%. Prevalensi balita stunting dan wasting di RS Prima Husada Malang tahun 2023 sebanyak 6 pasien, tahun 2024 sebanyak 6 pasien, dan pada tahun 2025 sebanyak 9 pasien.

Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka stunting di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya irreversible. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pola makan yang seimbang, pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan penting dalam memperburuk masalah stunting ini.

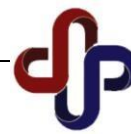
Dampak dari tingginya angka stunting sangatlah merugikan. Anak stunting pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan pada kemampuan belajar, pada pertumbuhan fisik dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. Upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk perkembangan anak. Selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

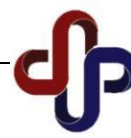
RS. Prima Husada Malang berupaya untuk menjaring balita stunting dan wasting untuk mendapatkan tatalaksana gizi lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama, agar kolaborasi setiap RS. Prima Husada Malang dengan rumah sakit lain dan FKTP di wilayahnya baik.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud



Pedoman Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* ini dimaksudkan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam pelayanan secara terarah, terstandar, terpadu,



dan berkualitas untuk pencegahan, penemuan, penanganan, pemantauan, serta evaluasi kasus stunting dan wasting.

2. Tujuan Umum

Pedoman kerja tim pelayanan *stunting* dan *wasting* ini disusun untuk mewujudkan pelayanan stunting dan wasting yang terstandar, terintegrasi, bermutu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan status gizi serta menurunkan angka stunting dan wasting.

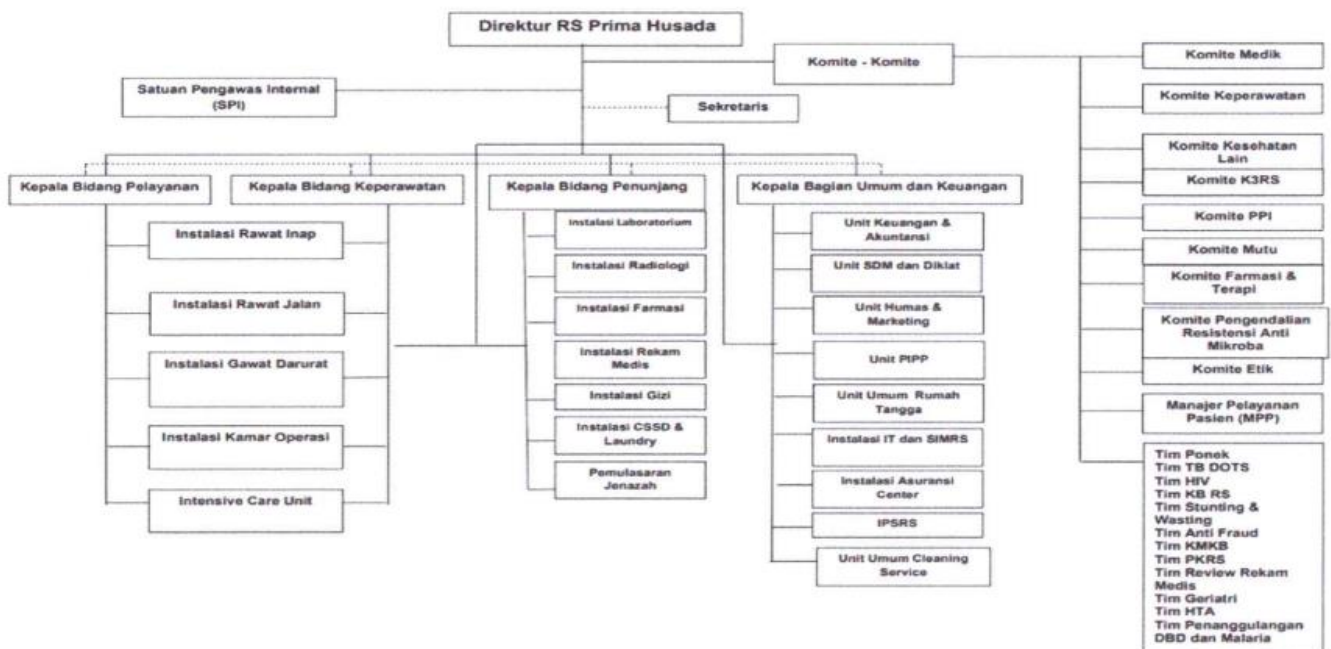
3. Tujuan Khusus

- a. Sebagai acuan bagi Tim Pelayanan Stunting dan Wasting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya.
- b. Menyeragamkan prosedur pelayanan mulai dari skrining, deteksi dini, diagnosis, tata laksana, rujukan, pemantauan, hingga tindak lanjut.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan serta lintas program dan lintas sektor dalam penanganan stunting dan wasting.
- d. Menjamin terselenggaranya pelayanan yang aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan sasaran.
- e. Meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan stunting dan wasting.
- f. Mendukung pencapaian target program perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting sesuai kebijakan nasional dan daerah.

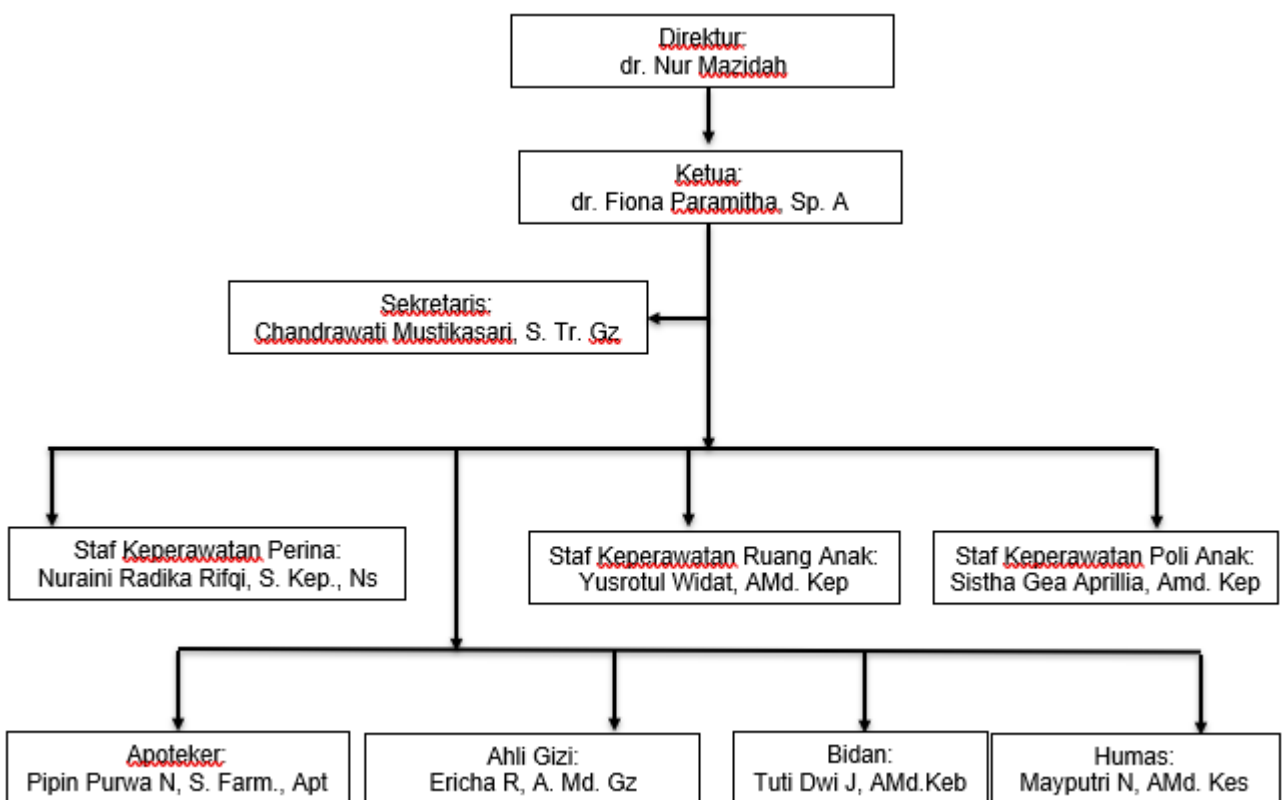


BAB II PENGORGANISASIAN

2.1 Struktur Organisasi (SOTK)



Gambar 1. SOTK Rumah Sakit



Gambar 2. SOTK Tim pelayanan Stunting dan Wasting



2.2 Susunan Tim Pelayanan *Stunting* dan Wasting

Ketua	: dr. Fiona Paramitha, Sp. A
Sekretaris	: Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz
Anggota	:
Staff Keperawat Poli Anak	: Sistha Gea Aprillia, Amd. Kep
Staff Keperawatan R. Anak	: Yusrotul Widat, AMd. Kep
Staff Keperawatan Perina	: Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns
Staff Kebidanan	: Tuti Dwi Jayati, AMd.Keb
Staff Instalasi Gizi	: Ericha Risdawati, A. Md. Gz
Staff Instalasi Farmasi	: Pipin Purwa Ningrum, S. Farm., Apt
Anggota Tim Humas	: Mayputri Nabilla, AMd. Kes

2.3 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Ketua Tim

- a. Kualifikasi
 - 1) Sarjana Kesehatan diutamakan dokter Spesialis Anak (dr.Sp.A)
 - 2) Berpengalaman di bidang stunting wasting minimal selama 3 tahun
 - 3) Mempunyai kemampuan dan ketrampilan komunikasi Informasi dan Edukasi
 - 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan, koordinasi, dan manajemen tim
 - 5) Memahami pedoman nasional penanganan stunting dan wasting serta standar pelayanan rumah sakit.
 - 6) Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi
- b. Uraian Tugas
 - 1) Memimpin embuat rencana program kerja Tim Stunting
 - 2) Melaksanakan semua program Tim Stunting
 - 3) Memimpin dan mengkoordinir semua pelaksanaan operasional tim Stunting secara efektif, efisien dan bermutu
 - 4) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat, kebijakan, laporan, kebutuhan dan keluhan Tim Stunting termasuk keluhan eksternal Tim
 - 5) Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Tim Stunting
 - 6) Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada dan kepanitiaanlainnya dan undangan dinas terkait
 - 7) Mengkoordinir semua laporan kegiatan tim stunting.
 - 8) Memonitor dan mengevaluasi semua pelaksanaan program kerja Tim Stunting
- c. Tanggung Jawab
 - 1) Bertanggungjawab pada Direktur RS Prima Husada
 - 2) Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monev semua program kerja tim stunting dan wasting RS secara paripurna.
 - 3) Bertanggungjawab terhadap laporan, penyajian data dan semua informasi yang dikeluarkan Tim dari hasil pelaksanaan program pelayanan Stunting dan wasting kepada Direktur RS PrimaHusada dan ataupun dari dinas terkait.
- d. Wewenang



- 1) anggota tim Stunting dan Wasting Menunjuk dan menetapkan sekretaris dan
- 2) Stunting dan Wasting Menentukan agenda setiap rapat Tim
- 3) melaksanakan program pelayanan kesehatan dan gizi Stunting Memerintahkan dan menugaskan staf dalam
- 4) terkait program stunting & wasting Meminta data dan informasi dari anggota
- 5) program Stunting dan Wasting sesuai perundangan atau regulasi yang berlaku. Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk

2. Sekretaris Tim

a. Kualifikasi

- 1) Tenaga kesehatan/tenaga administrasi kesehatan yang ditunjuk oleh ketua
- 2) Memiliki pendidikan minimal D-III
- 3) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang penurunan stunting dan wasting
- 4) Telah mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidangnya.

b. Uraian Tugas

- 1) Membuat dan mendokumentasikan surat keluar tim Stunting
- 2) Mengarsip surat masuk dan dokumen-dokumen tim Stunting
- 3) Membantu mengkoordinir semua usulan perencanaan pembuatan program kerja tim Stunting
- 4) Membantu pembuatan pedoman kerja tim Stunting
- 5) Membantu pembuatan spo terkait kegiatan program Layanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting Sejak Dini
- 6) Melakukan semua kegiatan administrasi tim Stunting
- 7) Menyebarkan informasi tentang : Regulasi, kebijakan, referensi, kepada semua anggota tim Stunting
- 8) Menyiapkan undangan, materi, daftar absensi, konsumsi, ATK, dan ruangan untuk rapat, pertemuan ataupun Diklat serta acara terkait program kerja Tim
- 9) Membantu membuat TOR baik untuk usulan kegiatan, diklat, alat dll.
- 10) Membantu pembuatan laporan triwulan program kerja tim Stunting.
- 11) Meminta atau menagih laporan kepada unit kerja pelaksana program terkait Stunting
- 12) Membantu menganalisis data hasil kegiatan program
- 13) Mendokumentasikan hasil dari pelayanan Kesehatan dan Gizi Stunting
- 14) Mengorganisir kebutuhan logistik tim Stunting
- 15) Membantu koordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal tim Stunting

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggungjawab pada ketua tim Stunting
- 2) Bertanggungjawab terhadap semua tugas-tugas administratif tim Stunting
- 3) Bertanggungjawab terhadap penyimpanan ataupun pengarsipan semua kelengkapan berkas: regulasi, referensi, persuratan, materi- materi KIE, dan yang terkait dengan program pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit.

d. Wewenang

- 1) Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit dari unit kerja pelaksana / terkait
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksana program pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit



- 3) Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada
- 4) Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja di lingkungan RS Prima Husada dan pihak luar melalui surat tertulis, email, dan telepon

3. Anggota Tim

a. Staf Keperawatan

- 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III Keperawatan atau Profesi Ners
 - b) Memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku
 - c) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang Pencegahan dan penanganan stunting dan wasting
 - d) Pernah mengikuti pelatihan stunting dan wasting
- 2) Uraian Tugas
 - a) Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien stunting dan wasting
 - b) Melakukan pengukuran tanda vital dan antropometri pasien
 - c) Memberikan asuhan keperawatan sesuai rencana terapi medis
 - d) Membantu pemantauan pemberian nutrisi dan terapi
 - e) Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.
- 3) Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab terhadap ketua tim penurunan prevalensi stunting dan wasting
 - b) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya.
- 4) Wewenang
 - a) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi
 - b) Melakukan pemantauan kondisi dan melaporkan pada dokter.

b. Staf Kebidanan

- 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III Kebidanan atau Profesi Bidan
 - b) Memiliki STR dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) yang masih berlaku
 - c) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang penanggulangan pasien stunting dan wasting.
 - d) Pernah mengikuti seminar atau pelatihan tentang stunting dan wasting.
- 2) Uraian Tugas
 - a) Melakukan skrining awal risiko stunting dan wasting pada bayi
 - b) Melakukan koordinasi dengan tim penurunan prevalensi stunting dan wasting dalam rangka kegiatan operasional.
 - c) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - d) Melakukan evaluasi kegiatan operasional
- 3) Tanggung Jawab
 - a) Menjamin Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya
 - b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting.
- 4) Wewenang
 - a) Melakukan pelayanan kebidanan sesuai kompetensi
 - b) Melakukan deteksi dini masalah tumbuh kembang anak
 - c) Memberikan konseling kesehatan ibu dan anak.

c. Staf Gizi

- 1) Kualifikasi
 - a) Pendidikan minimal Diploma III atau Sarjana Gizi/Nutrisi
 - b) Memiliki STR Tenaga Gizi dan SIP yang masih berlaku
 - c) Memiliki kompetensi dalam asuhan gizi klinik pada anak.



-
- d) Pernah mengikuti seminar atau pelatihan terkait stunting.
- 2) Uraian Tugas
- a) Melakukan tata laksana pasien stunting dan wasting di rumah sakit
- b) Pemantauan intervensi terhadap pasien stunting dan wasting
- c) Melakukan koordinasi dengan ketua tim penurunan prevalensi stunting dan wasting terkait dengan pelayanan Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- 3) Tanggung Jawab
- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan pelaksanaan pelayanan Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- b) Bertanggung jawab kepada ketua tim Penurunan prevalensi stunting dan wasting,
- 4) Wewenang
- a) Menentukan rencana diet pasien
- b) Memberikan edukasi dan konseling gizi.
- c) Melakukan pengukuran antropometri
- d) Melakukan surveilans pasien stunting dan wasting
- d. Staf Farmasi
- 1) Kualifikasi
- a) Pendidikan minimal Diploma III Farmasi atau Profesi Apoteker
- b) Memiliki STR Tenaga Kefarmasian dan SIPA/SIK yang masih berlaku
- c) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- 2) Uraian Tugas
- a) Melaksanakan pelayanan obat untuk Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- b) Melakukan koordinasi dengan ketua tim Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- c) Melaksanakan evaluasi terhadap kasus-kasus terkait obat Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- 3) Tanggung Jawab
- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan kefarmasian.
- b) Bertanggung jawab kepada ketua tim Penurunan prevalensi stunting dan wasting
- 4) Wewenang
- a) Mengelola terhadap ketersediaan Obat-obatan Stunting dan wasting.
- b) Mengelola terhadap pengeluaran Obat-obatan Stunting dan wasting.
- e. Staf Humas
- 1) Kualifikasi
- a) Memiliki pengetahuan tentang stunting dan wasting.
- b) Pernah mengikuti seminar atau pelatihan tentang stunting dan wasting.
- 2) Uraian Tugas
- a) Membantu dalam koordinasi antar unit rumah sakit dan instalasi luar rumah sakit untuk kelancaran pelaksanaan program penurunan prevalensi rumah sakit.
- b) Melakukan koordinasi dengan tim penurunan prevalensi stunting dan wasting dalam rangka kegiatan operasional.
- c) Melakukan evaluasi kegiatan operasional
- 3) Tanggung Jawab
- a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya
- b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim Pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting.
- 4) Wewenang
-



- a) Mengembangkan media komunikasi kesehatan
- b) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit dan masyarakat.
- c) Melakukan jejarin rujukan dengan FKTP sekitar

2.4 Tata Hubungan Kerja

1. Hubungan Internal Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

a. Ketua Tim dengan Anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- 1) Ketua Tim mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.
- 2) Ketua Tim mengatur pembagian tugas sesuai kompetensi anggota tim Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*.
- 3) Ketua Tim memimpin rapat koordinasi secara berkala Tim *Stunting* dan *Wasting*.
- 4) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada direktur.

b. Antar Anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- 1) Anggota tim melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok, kompetensi, dan standar operasional prosedur.
- 2) Anggota tim berkoordinasi dengan anggota tim lainnya dalam penanganan kasus pasien *stunting* dan *wasting*
- 3) Anggota tim melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan secara tepat waktu.
- 4) Anggota tim menyampaikan kendala dan usulan perbaikan kepada ketua tim.
- 5) Dilakukan diskusi tim secara berkala

2. Hubungan Unit Pelayanan di rumah Sakit

a. Instalasi Rawat Jalan

- 1) Tim *Stunting* dan *Wasting* melakukan skrining status gizi pada bayi, balita, dan anak.
- 2) Tim *Stunting* dan *Wasting* Mengidentifikasi pasien yang berisiko atau mengalami *stunting* dan *wasting*.
- 3) Tim *Stunting* dan *Wasting* Merujuk pasien ke dokter spesialis anak, ahli gizi, atau unit terkait sesuai indikasi.

b. Instalasi Rawat Inap

- 1) Tim *Stunting* dan *Wasting* Memberikan pelayanan medis, asuhan keperawatan, dan terapi gizi bagi pasien yang memerlukan perawatan.
- 2) Tim *Stunting* dan *Wasting* Melakukan pemantauan perkembangan klinis dan status gizi selama perawatan.

c. Instalasi Gizi

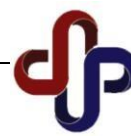
- 1) Melakukan asesmen gizi, menetapkan diagnosis gizi, serta menyusun intervensi dan monitoring gizi.
- 2) Menyediakan diet sesuai kondisi klinis pasien.
- 3) Memberikan edukasi gizi kepada pasien dan keluarga.

d. Instalasi Farmasi

- 1) Menyediakan obat, vitamin, mineral, dan produk nutrisi sesuai resep dan standar pelayanan.
- 2) Memberikan informasi penggunaan obat dan suplemen kepada pasien.

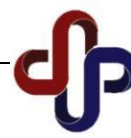
3. Hubungan Eksternal Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*

- a. Tim melakukan koordinasi mengenai pemantauan pertumbuhan, status gizi, dan kepatuhan terhadap intervensi di wilayah kerja. Melakukan koordinasi dalam sistem rujukan dan rujuk balik pasien.
- b. Menyampaikan ringkasan medis, hasil pemeriksaan, terapi, serta rencana tindak lanjut setelah pasien pulang kepada jejaring wilayah kerja pasien.
- c. Menerima rujukan pasien yang memerlukan pelayanan lanjutan.
- d. Memberikan umpan balik atas hasil pemeriksaan dan tata laksana kepada



fasilitas perujuk.

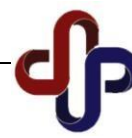
- e. Mendukung kesinambungan pelayanan melalui komunikasi yang efektif.
- f. Melaksanakan pelaporan program sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Berpartisipasi dalam kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pelatihan terkait pelayanan stunting dan wasting.
- h. Mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perbaikan gizi.
- i. Memberikan edukasi kepada keluarga melalui jejaring pelayanan.



BAB III TATALAKSANA

1.1 Identifikasi dan Penetapan Pasien Risiko *Stunting* dan *Wasting*

1. Pelayanan *stunting* dan *wasting* dilaksanakan secara multidisiplin oleh Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tindak lanjut. Pelayanan diberikan sesuai standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, serta kebijakan yang berlaku.
 - a. Sasaran pelayanan meliputi:
 - Bayi usia 0–11 bulan.
 - Balita usia 12–59 bulan.
 - Anak dengan risiko atau diagnosis *stunting* dan/atau *wasting*.
 - Ibu hamil dengan risiko melahirkan bayi *stunting*.
 - Orang tua atau pengasuh sebagai bagian dari edukasi dan pendampingan.
 - b. Komponen asesmen: asesmen medis DPJP, asesmen gizi oleh nutrisisionis, asesmen tumbuh kembang, pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan penunjang sesuai indikasi, asesmen psikososial keluarga.
 - c. Setiap bayi dan balita yang datang ke rumah sakit menjalani skrining meliputi:
 - Pengukuran berat badan.
 - Pengukuran panjang badan/tinggi badan.
 - Pengukuran lingkar lengan atas (bila diperlukan).
 - Penilaian status gizi berdasarkan standar yang berlaku.
 - Identifikasi faktor risiko.
 - d. Perhitungan dan interpretasi z-score berdasarkan standar WHO berupa PB/U atau TB/U (deteksi *stunting*) dan BB/PB atau BB/TB (deteksi *wasting*) dengan klasifikasi status gizi:
 - 1) *Stunting* : PB/U atau TB/U < -2 SD
 - 2) *Wasting* : BB/PB atau BB/TB < -2 SD
 - 3) *Severe wasting* : BB/PB atau BB/TB < -3 SD
 - e. Pengidentifikasian berat badan lahir rendah atau prematur, riwayat gagal tumbuh, penyakit kronis atau infeksi berulang, kelainan bawaan yang memengaruhi pertumbuhan, kesulitan makan atau gangguan pemberian makan, asupan gizi yang tidak adekuat, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang beresiko.
 - f. Penetapan ditetapkan sebagai risiko dan/ atau *wasting* berdasarkan:
 - Hasil skrining antropometri.
 - Hasil penilaian faktor risiko.
 - Pertimbangan klinis dokter.
 - Penilaian awal tenaga gizi.
 - g. Pasien yang telah ditetapkan sebagai risiko dilakukan:
 - Asesmen medis dan gizi komprehensif.
 - Pemeriksaan penunjang sesuai indikasi.
 - Masuk dalam program pemantauan Tim *Stunting* dan *Wasting*.
 - Pemberian edukasi kepada orang tua/pengasuh.
 - Penentuan rencana intervensi awal.
 - Penjadwalan kontrol atau rawat lanjut.
 - h. Tatalaksana medis dilakukan oleh DPJP meliputi:
 - Terapi penyakit penyerta (infeksi, kronis, dll)
 - Stabilisasi kondisi umum
 - Penanganan komplikasi gizi buruk
 - Kolaborasi dengan spesialis lain



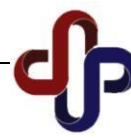
- Penentuan rawat jalan/rawat inap
 - i. Seluruh proses identifikasi dan penetapan risiko didokumentasikan dalam:
 - Rekam medis pasien.
 - Form skrining gizi.
 - Form antropometri.
 - CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi).
 - Register Tim Stunting dan Wasting.
 - 2. Identifikasi dilakukan di seluruh unit pelayanan, antara lain:
 - a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - b. Rawat Jalan (terutama poli anak dan poli kandungan)
 - c. Rawat Inap
 - 3. Pasien yang memenuhi kriteria dirujuk kepada Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* untuk penanganan lanjut.
- 1.2 Asesmen dan Penilaian Komprehensif
- Tim pelayanan stunting dan wasting melakukan asesmen menyeluruh, meliputi:
1. Anamnesis
 - a. Faktor Ibu
 - 1) Riwayat status gizi ibu
 - 2) Riwayat ibu di masa prakonsepsi
 - 3) Riwayat kehamilan
 - 4) Riwayat penyakit infeksi
 - b. Faktor Anak
 - 1) Riwayat BBLR
 - 2) Praktik pemberian ASI
 - 3) Pola pemberian MPASI
 - 4) Riwayat imunisasi
 - 5) Riwayat penyakit infeksi
 - c. Faktor Lingkungan
 - 1) Kondisi dan dukungan keluarga
 - 2) Pola asuh dan pola makan
 - 3) Sanitasi lingkungan
 2. Pemeriksaan Fisik
 - a. Pengukuran Antropometri
 - 1) Pengukuran antropometri berupa BB, PB/TB, dan LILA (usia 6-59 bulan)
 - 2) Perhitungan dan interpretasi z-score berdasarkan standar WHO berupa PB/U atau TB/U (deteksi stunting) dan BB/PB atau BB/TB (deteksi wasting) dengan klasifikasi status gizi:
 - Stunting : PB/U atau TB/U < -2 SD
 - Wasting : BB/PB atau BB/TB < -2 SD
 - Severe wasting : BB/PB atau BB/TB < -3 SD
 - b. Tanda klinis kekurangan gizi
 - c. Deteksi edema dan komplikasi
 3. Pemeriksaan Penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium
 - b. Skrining TBC
 - c. Skrining kelainan metabolik

1.3 Penyusunan Rencana Pelayanan Terpadu

1. Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* menyusun rencana pelayanan berdasarkan



- hasil assesmen.
2. Rencana pelayanan meliputi:
 - a. Tata laksana medis sesuai diagnosis
 - b. Intervensi gizi
 - c. Edukasi
 - d. Suplementasi dan terapi nutrisi
 - e. Dukungan psikososial keluarga
 3. Rencana pelayanan didokumentasikan dalam rekam medis.
 4. Rencana dikomunikasikan kepada orang tua atau keluarga pasien, serta seluruh anggota tim.
- 1.4 Pelaksanaan Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*
1. Setiap anggota tim melaksanakan intervensi sesuai rencana pelayanan, dan kompetensi masing-masing profesi.
 2. Pelayanan dilakukan secara multidisiplin.
 3. Dilakukan koordinasi antar anggota tim.
 4. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
- 1.5 Monitoring Evaluasi Pasien *Stunting* dan *Wasting*
1. Tim melakukan pemantauan kondisi pasien *stunting* dan/atau *wasting* secara berkala.
 2. Dilakukan evaluasi meliputi:
 - a. Perkembangan kondisi dan status gizi
 - b. Kepatuhan terhadap intervensi
 - d. Risiko komplikasi
 3. Dilakukan penyesuaian rencana pelayanan bila diperlukan.



BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

1. Tujuan Monitoring
 - a. Mengidentifikasi masalah secara dini
 - b. Mencegah komplikasi
 - c. Menjamin pelayanan sesuai standar
2. Monitoring Tim
 - a. Diskusi kasus multidisiplin
 - b. Rapat Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* mingguan/bulanan
 - c. Evaluasi rencana pelayanan
3. Monitoring Kepatuhan terhadap Prosedur
 - a. Kepatuhan terhadap asesmen *stunting* dan *wasting*
 - b. Kepatuhan dokumentasi rekam medis
 - c. Kepatuhan terhadap pencatatan dan pelaporan

4.2 Evaluasi

1. Evaluasi Klinis Pasien
 - a. Perkembangan kondisi dan status gizi
 - b. Kepatuhan terhadap intervensi
 - d. Risiko komplikasi

Bila hasil tidak optimal, maka:

 - a. Dilakukan revisi rencana pelayanan
 - b. Dilakukan konsultasi tambahan
 - c. Dilakukan intervensi lanjutan
2. Evaluasi Program Pelayanan *Stunting* dan *Wasting*
 - a. Tujuan:
 - 1) Menilai efektivitas pelayanan
 - 2) Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
 - 3) Mendukung program peningkatan mutu (PMKP)
 - b. Evaluasi sumber daya
 - 1) Ketersediaan SDM
 - 2) Ketersediaan sarana dan prasarana
 - 3) Kebutuhan pelatihan

4.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan *Stunting* dan *Wasting* kepada manajemen rumah sakit

1. Pelaporan Internal

Pelaporan kegiatan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/tahunan).
2. Pelaporan Eksternal

Data pasien *stunting* dan/atau *wasting* dilaporkan pada Dinas Kesehatan wilayah setempat untuk dilakukan pengecekan dan pencatatan dalam aplikasi "PELITA KESMAS".

BAB V PENUTUP

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pelayanan *stunting* dan *wasting* yang komprehensif, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan, dengan melibatkan tim multidisiplin sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung terselenggaranya pelayanan yang bermutu, efektif, efisien, serta berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan adanya pedoman ini, seluruh anggota Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* serta unit terkait di rumah sakit diharapkan dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional, terintegrasi, serta sesuai dengan standar pelayanan, standar akreditasi rumah sakit, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta peningkatan mutu pelayanan *stunting* dan *wasting* secara berkelanjutan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan evaluasi serta peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pelayanan, serta perubahan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pelayanan *stunting* dan *wasting* di rumah sakit dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan berorientasi pada keselamatan pasien. Demikian Pedoman Kerja Tim pelayanan *stunting* dan *wasting* Rumah Sakit Prima Husada Sukkorejo disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 25 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah